

Prevención de Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica

Estrategias Basadas en Evidencia para el Cuidado Crítico

PRESENTADO POR: JUAN ZAVALITA

Contenido de la Sesión

1. Definición y alcance del problema
2. Impacto clínico en la unidad
3. Fisiopatología y colonización
4. Objetivos
5. Factores de riesgo asociados
6. Medidas preventivas
5. Conclusiones y recomendaciones para la práctica clínica.

Antecedentes Clínicos

Definición y Diagnóstico

La Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica (NAVM) se define como una infección nosocomial que compromete directamente el parénquima pulmonar de pacientes bajo asistencia respiratoria invasiva.

El criterio clínico estándar establece su aparición tras un periodo de **48 horas o más** desde el inicio de la intubación endotraqueal.

Representa una de las complicaciones más críticas en terapia intensiva, derivada de la ruptura forzada de las barreras anatómicas defensivas.



Impacto de la Infección

Consecuencias Clínicas

La NAVM incrementa de forma alarmante la mortalidad atribuible en el paciente crítico entre un **20% y un 30%**.

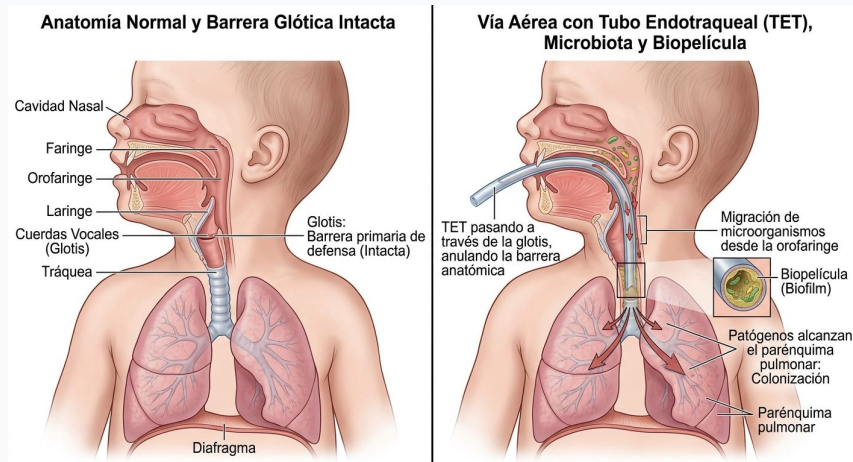
Asimismo, genera una prolongación crítica de la hospitalización, sumando un promedio estimado de **7 a 10 días de estancia adicionales** por cada evento detectado.

Análisis Económico

El manejo terapéutico eleva el costo operativo del paciente en un **40%**, debido al uso prolongado de antibióticos de amplio espectro e insumos avanzados.

La implementación estricta de paquetes preventivos (bundles) demuestra mitigar estos costos en un **25%** en la unidad.

Mecanismos Fisiopatológicos



Colonización y Biopelícula

El tubo endotraqueal anula directamente la acción de la glotis, que es la barrera primaria de defensa física en la vía aérea superior.

La migración de microorganismos desde la orofaringe desciende rápidamente hacia el tracto respiratorio inferior.

La acumulación de secreciones favorece la formación de una **biopelícula (biofilm)** patógena dentro del lumen del dispositivo, facilitando la colonización progresiva del parénquima pulmonar.

Objetivos del Protocolo



Mitigar Riesgos

Identificar oportunamente los factores de riesgo modificables relacionados al manejo directo del respirador y la vía aérea.



Evidencia Clínica

Aplicar de forma sistemática cuidados validados científicamente para inhibir el crecimiento microbiano en la intubación.



Seguridad

Fomentar una cultura proactiva de seguridad mediante la ejecución rigurosa de paquetes de medidas preventivas (bundles).

Factores de Riesgo Clave



Manipulación excesiva de la vía aérea: La frecuencia de aspiración de secreciones y la apertura injustificada del circuito respiratorio incrementan la contaminación biológica.



Duración de la ventilación: La permanencia prolongada del tubo endotraqueal aumenta de forma exponencial la probabilidad de colonización bacteriana.



Eventos de reintubación: Las maniobras urgentes o repetidas introducen de manera agresiva flora patógena de la orofaringe hacia el pulmón.



Condiciones clínicas de base: La inmadurez del sistema inmunitario del paciente neonatal y la severidad del cuadro inicial condicionan una susceptibilidad crítica.

Medidas Preventivas (Bundles)

Pilar del Paquete	Acción Operativa Específica	Justificación Clínica de la Evidencia
Higiene de Manos	Asepsia estricta antes y después de interactuar con el paciente o el circuito.	Elimina la transmisión cruzada de patógenos exógenos a la vía aérea.
	Mantener elevación óptima de la cabecera: MathML para ángulos 30 y 45 grados según las reglas del sistema	
	30	
Posicionamiento	o	
	a	Previene la microaspiración pasiva del contenido orofaríngeo y gástrico.
	45	

Conclusiones del Módulo

100%

APEGO AL PROTOCOLO

Un Desafío de Calidad

La adopción estricta de las directrices preventivas es la única vía demostrada para abatir la incidencia de NAVM en cuidados críticos.

La estandarización diaria basada en evidencia científica robusta es el puente indispensable para garantizar una atención de alta especialidad y la seguridad del paciente crítico.

El compromiso continuo con la actualización de enfermería representa la base fundamental del éxito en los resultados terapéuticos de la UCIN.

¡Gracias!

Por su atención y compromiso con la excelencia clínica

Enfermería Neonatal de Alta Especialidad
Prevención de Infecciones Nosocomiales Críticas